



Questions d'examens : Les Hématuries

Résidanat

Année universitaire 2025

Dr Awatef AZZABI

Dr Sameh Mabrouk

Dr Ghassen Tlili

Dr Salsabil Nouir

QCM

1. L'hématurie microscopique:

- A. Est visible à l'œil nu
- B. Est définie par la présence d'hématie $> 10/\text{mm}^3$ dans les urines
- C. Doit être confirmée par un ECBU
- D. Peut être due à une lithiase urinaire
- E. Peut être d'origine néphrologique

2. Parmi les valeurs suivantes d'hématurie, la(les) quelle(s) est (sont) pathologique(s) :

- A- Hématies $> 10/\text{ml}$
- B- Hématies $> 1000/\text{ml}$
- C- Hématies $> 10000/\text{ml}$
- D- Hématies $> 10/\text{mm}^3$
- E- Hématies $= 500/\text{ml}$

3. L'hématurie macroscopique:

- A. Est visible à l'œil nu
- B. Est définie par la présence d'hématie $> 10\,000/\text{ml}$ dans les urines
- C. Doit être confirmée par un ECBU
- D. Peut être de coloration brunâtre
- E. Peut être d'origine néphrologique

4. Des urines colorées non hématuriques peuvent se voir dans les situations suivantes :

- A. Prise de myrtilles
- B. Prise de rifampicine
- C. rhabdomyolyse
- D. Prise d'AINS
- E. Prise de vitamine B12

5. Quels sont les signes en faveur de l'origine glomérulaire de l'hématurie

- A- La présence de caillots
- B- Une leucocyturie égale à 40 000 éléments par minute
- C- Une protéinurie de 3 g /24h
- C- La présence d'insuffisance rénale
- D- Le caractère normal du cliché de l'appareil urinaire sans préparation
- E- présence de cylindres hématiques

6. Concernant l'hématurie, quelles affirmations sont exactes ?

- A- Les bandelettes urinaires ne détectent que l'hématurie d'origine glomérulaire
- B- La présence d'hématies déformées témoigne de l'origine glomérulaire
- C- L'hématurie microscopique ne justifie pas la réalisation d'examens morphologiques
- D- La présence de caillots oriente vers une étiologie urologique
- E- L'hématurie glomérulaire est toujours microscopique

7. Parmi les propositions suivantes: lesquelles sont en faveur de l'origine néphrologique de l'hématurie:

- A. Tabagisme
- B. Exposition toxique (aniline, colorants)
- C. Présence d'une protéinurie
- D. Présence d'une HTA
- E. Présence de caillots

8. L'origine glomérulaire d'une hématurie peut être suspectée devant:

- A. La présence de cylindres hématiques
- B. Une hématurie terminale
- C. Une protéinurie à 3 g/24H
- D. La présence de caillots
- E. Une hématurie initiale

9. Concernant les hématuries, quelles affirmations sont exactes ?

- A - les bandelettes réactives détectent plus de 5 hématies par mm³
- B - une hématurie glomérulaire est caractérisée par des hématies déformées
- C - les cylindres hématiques caractérisent les hématies glomérulaires
- D- les hématuries d'effort sont exclusivement glomérulaires
- F- La présence de caillots oriente vers une étiologie glomérulaire

10. Avant tout examen complémentaire radiologique, on peut suspecter l'origine glomérulaire d'une hématurie macroscopique sur :

- A- La présence de caillots
- B- Une leucocyturie
- C- Une hypertension artérielle
- D- Le caractère douloureux de l'hématurie
- E- La présence d'une hypocomplémentémie

11. La présence de cylindres hématiques :

- A -est la règle en cas d'hématurie terminale
- B -témoigne d'une hématurie d'origine glomérulaire
- C -peut s'observer dans le syndrome néphrotique pur
- D- peut s'observer dans la maladie de Berger
- E -peut s'observer en cas d'hémolyse intravasculaire

12. Un sujet de 28 ans présente, après une angine, une hématurie macroscopique. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A - syndrome néphrotique par lésion glomérulaire minime
- B -maladie de Berger
- C –vascularite à ANCA
- D –tuberculose urinaire
- E -tubulopathie congénitale

13. Une hématurie macroscopique peut être retrouvée en cas :

- A- lithiase
- B - purpura rhumatoïde
- C -néphrose lipoïdique
- D -maladie de Berger
- E -glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique

14. Une hématurie microscopique est présente dans les néphropathies glomérulaires primitives suivantes:

- A- La lésion glomérulaire minime
- B- La glomérulonéphrite extra-membraneuse
- C- La glomérulonéphrite segmentaire et focale à dépôts mésangiaux d'IgA
- D- La glomérulonéphrite membrano-proliférative
- F- La glomérulonéphrite de type hyalinose segmentaire et focale

15. Une hématurie microscopique détectée à la bandelette, peut orienter vers :

- A- Une lithiase des voies urinaires
- B- Une infection urinaire
- C- Une porphyrie
- D- Une tumeur de la vessie
- E- Une prise de Rifampicine

16. Les affirmations vraies sont :

- A - Une hématurie macroscopique oriente vers une étiologie plus grave qu'une hématurie microscopique
- B - Une hématurie microscopique isolée oriente le plus souvent vers une étiologie néoplasique
- C - Une hématurie microscopique dépistée à la bandelette urinaire nécessite une confirmation par un examen cytologique urinaire
- D - Une hématurie macroscopique terminale oriente vers une origine rénale du saignement
- E - Une origine vésicale ne peut pas être envisagée en cas d'hématurie totale

17. Une hématurie associée à une douleur lombaire peut évoquer toutes les étiologies sauf une, laquelle ?

- A- Lithiase rénale
- B- Nécrose papillaire
- C- Infarctus rénal
- D- Thrombose de la veine rénale
- F- Glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique

18. Devant un syndrome néphritique aigu de l'adulte, on évoque :

- A- une GNA post infectieuse
- B- une glomérulonéphrite membranoproliférative
- C- un purpura rhumatoïde
- D- une amylose rénale
- E- une néphropathie lupique

19. Devant une hématurie avec une hypocomplémentémie, on peut évoquer :

- A- une néphropathie lupique en poussée
- B- une maladie de Berger
- C- une GNA post streptococcique
- D- une GNMP
- E- un syndrome d'Alport

20. Les anomalies biologiques suivantes permettent d'évoquer le diagnostic de GNA post infectieuse :

- A- Hypoprotidémie
- B- Baisse du complément total CH50
- C- ANCA positifs
- D- Elévation des ASLO
- E- hématies à 300000/ml

21. Parmi les signes suivants, indiquer ceux qui sont en faveur de l'origine streptococcique d'une glomérulonéphrite post infectieuse :

- A- hématurie
- B- protéinurie
- C- élévation des antistreptolysine O (ASLO) à deux dosages
- D- baisse du complément
- E- augmentation de la vitesse de sédimentation

22. Au cours d'une GNA post infectieuse, l'examen anatomopathologique en immunofluorescence montre des dépôts de :

- A- IgA
- B- IgM
- C- IgG
- D- C3
- E- C4

23. La GNA post infectieuse bénigne est caractérisée par :

- A- Une baisse constante de C3
- B- la présence d'une cryoglobulinémie
- C- l'existence d'une prolifération endo et extra capillaire
- D- la présence d'une hématurie avec caillots
- E- Des AAN positifs

24. Parmi les signes suivants, quels sont ceux qui sont constants au cours d'une GNA post infectieuse

- A- hématurie
- B- protéinurie > 3g/j
- C- natriurèse effondrée
- D- hypocomplémentémie
- E- ASLO > 200UI

25. Que vous évoque en premier l'association hématurie totale + gros rein unilatéral chez un homme de plus de 45 ans, ayant des antécédents familiaux de néphropathie ?

- A- un syndrome d'Alport
- B- un cancer du rein
- C- une tuberculose rénale
- D- une anomalie de la jonction pyélo-urétérale
- F- une polykystose rénale

26-Un homme âgé de 23 ans consulte pour une hématurie macroscopique. Il est suivi depuis quelques mois pour une diminution de l'acuité auditive, que l'audiogramme a caractérisée comme prépondérante dans les aigus. On relève d'autres cas, dans sa famille, de surdité et d'atteinte glomérulaire. Il s'agit :

- A- D'une pyélonéphrite chronique
- B- D'un syndrome d'Alport
- C- D'une polykystose rénale
- D- D'une glomérulonéphrite à dépôts d'IgA
- E- D'une hydronéphrose

27. Un homme de 45 ans consulte pour un épisode d'hématurie macroscopique. L'interrogatoire retrouve la notion de mort au jeune âge de 2 oncles par AVC. L'examen révèle une TA à 170/90 mmHg, un contact lombaire bilatéral et ne retrouve pas d'œdèmes. Le diagnostic le plus probable est :

- A la maladie de Berger
- B un cancer du rein
- C la polykystose rénale
- D le syndrome d'Alport
- E une amylose rénale

Cas cliniques

Cas clinique n° 1

Un patient de 26 ans chez lequel ont été découvertes une protéinurie à 2.3 g/24 h et une hématurie microscopique. La P.A. est à 150/80 mmHg, la clairance de la créatinine à 100 ml/mn. Il n'y a pas d'anomalie morphologique des reins et des voies excrétrices urinaires à l'échographie. Bilan immunologique négatif.

1. Indiquez parmi les investigations ci-dessous, la plus appropriée pour poser le diagnostic

- A- UIV
- B- Scintigraphie rénale
- C- Ponction biopsie rénale
- D- Urétéro-pyélographie rétrograde
- F- Cystoscopie

2. Le patient présente une prolifération segmentaire et focale avec des dépôts mésangiaux granuleux d'IgA et +/- C 3. Indiquez parmi les étiologies ci-dessous, le diagnostic le plus approprié.

- A- Syndrome d'Alport
- B- Néphropathie lupique
- C- Cryoglobulinémie
- D- Maladie de Berger
- E- Vascularite à ANCA

Cas clinique n° 2 :

Un homme de 47 ans diabétique sous insuline. Il a présenté 10 jours après une angine, une hématurie macroscopique sans caillot et indolore.

A l'examen clinique : TA 175/95mmHg, d'œdèmes de type rénal, absence de lombalgie et de contact lombaire, urine claire. A la bandelette urinaire : protéines ++ ; sang++ ; sucre = +. Protéinurie à 2.5g/j

1. Les arguments en faveur de l'origine glomérulaire de cette hématurie sont les suivants :

- A- sexe masculin
- B- HTA
- C- Lombalgie
- D- Protéinurie à 2.5 g/j
- E- Sucre à +

2. Quel diagnostic étiologique évoquez-vous ?

- A- Syndrome d'Alport
- B- Néphropathie lupique
- C- GNA post infectieuse
- D- Polykystose rénale
- E- vascularite à ANCA

3. Quel examen para-clinique pratiquez-vous pour confirmer le diagnostic ?

- A- Echographie rénale
- B- Dosage du complément sérique
- C- Ponction biopsie rénale
- D- dosage des anticorps anti-cytoplasmiques
- E- Cystoscopie

Cas clinique n°3:

Un homme de 31 ans présente, 2 jours après une angine, un œdème des paupières et des urines rares et anormalement colorées. A l'examen, on note une prise de poids de 3 kg et une tension artérielle à 135/85 mm Hg et à la bandelette urinaire : protéinurie+++ hématurie+++.

1. Le diagnostic le plus probable est :

- A- Néphropathie à IgA
- B- Néphropathie lupique
- C- Glomérulonéphrite aigue post-infectieuse
- D- Glomérulonéphrite membranoproliférative
- E- Amylose rénale

2. Le tableau clinique de cette maladie est celui d'une :

- A- Glomérulonéphrite rapidement progressive
- B- Syndrome néphritique aigu
- C- Néphrite interstitielle aiguë
- D- Néphropathie vasculaire aiguë
- E- Glomérulonéphrite chronique

3. Quel est l'examen qui permet de confirmer votre diagnostic ?

- A – Electrophorèse des protéides
- B – Radiographie de thorax
- C – Ponction biopsie rénale
- D – Biopsie cutanée
- E – Dosage du complément

4. Quel est l'aspect histologique de cette maladie ?

- A – Prolifération endo-capillaire
- B – Néphropathie vasculaire
- C – Synéchies floculo-capsulaires
- D – Prolifération mésangiale segmentaire et focale avec dépôts mésangiaux d'IgA
- E – Epaissement des membranes basales des capillaires glomérulaires

Objectif n°1 : Définir l'hématurie macroscopique et l'hématurie microscopique.

4. L'hématurie microscopique:

- F. Est visible à l'œil nu
- G. Est définie par la présence d'hématie $> 10/\text{mm}^3$ dans les urines
- H. Doit être confirmée par un ECBU
- I. Peut être due à une lithiase urinaire
- J. Peut être d'origine néphrologique

5. L'hématurie macroscopique:

- F. Est visible à l'œil nu
- G. Est définie par la présence d'hématie $> 10\,000/\text{ml}$ dans les urines
- H. Doit être confirmée par un ECBU
- I. Peut être de coloration brunâtre
- J. Peut être d'origine néphrologique

6. Concernant l'hématurie:

- A. La présence d'hématurie à la bandelette urinaire doit être confirmée par l'examen cytologique quantitatif des urines
- B. La présence d'hématies $< 10/\text{mm}^3$ est considérée comme une hématurie physiologique
- C. L'hématurie macroscopique a la même valeur diagnostique que l'hématurie microscopique
- D. Il y'a un parallélisme entre l'importance du saignement et la gravité de la maladie
- E. Une hématurie microscopique n'impose pas une enquête étiologique

Objectif n°2 : Distinguer une hématurie d'une coloration anormale des urines d'une autre origine.

2. Le diagnostic différentiel d'une hématurie comporte:

- A. Une urétrorragie
- B. Une hémospérmié
- C. Une réctorragie
- D. Une hémoglobinurie
- E. Une intoxication aux organophosphorés

Objectif n°4 : Suspecter l'origine d'une hématurie selon son caractère initial, terminal ou total.

5. L'hématurie terminale:

- A. Nécessite la réalisation du ECBU
- B. Est d'origine rénale
- C. Peut être due à une tumeur vésicale
- D. Peut être due à une hypertrophie bénigne de la prostate
- E. Peut évoluer vers une hématurie totale

6. L'hématurie initiale:

- A. Est d'origine rénale
- B. Peut être due à une tumeur vésicale
- C. Peut être due à un cancer de la prostate
- D. Peut être due à une hypertrophie bénigne de la prostate
- E. Peut évoluer vers une hématurie totale

Objectif n°5 : Distinguer l'origine urologique d'une origine néphrologique d'une hématurie à partir des données cliniques et biologiques.

7. Parmi les propositions suivantes: lesquelles sont en faveur de l'origine urologique de l'hématurie:

- F. Tabagisme
- G. Exposition toxique (aniline, colorants)
- H. Présence d'une protéinurie
- I. Présence d'une HTA
- J. Présence de caillots

Objectif n°10 : Citer les principales causes d'hématurie d'origine rénale, vésicale et uréthro- prostatique.

8. Une hématurie caillotante:

- A. Peut être due à une glomérulonéphrite membrano-proliférative
- B. Peut être due à une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse
- C. Peut être due à une lithiase pyélique
- D. Peut être due à une tumeur vésicale
- E. Peut se compliquer de rétention vésicale complète

Cas clinique:

Monsieur MB âgé de 65 ans, instituteur et tabagique à 40 PA consulte aux urgences pour une hématurie macroscopique. Il décrit des urines rouges depuis 48 h, avec une aggravation depuis quelques heures. Il n'y a pas de facteur déclenchant. Il présente par ailleurs des brûlures mictionnelles et une sensation d'impériosité depuis le début de l'hématurie, il ne s'est jamais plaint d'aucun symptôme urologique auparavant. Le patient est en bon état général, il vous tend un bocal contenant quelques millilitres d'urines rouges, correspondant à sa dernière miction.

Objectif n°2 : Distinguer une hématurie d'une coloration anormale des urines d'une autre origine.

Question 1 : quels sont les diagnostics différentiels d'une hématurie ?

- A. Une urétrorragie
- B. Une alimentation riche en viande rouge
- C. Une alimentation riche en betterave
- D. La prise de Rifampicine
- E. Une hémoglobinurie par hémolyse

L'examen physique est sans particularité. Le TR n'est pas douloureux, la prostate est souple et non volumineuse, il n'y a pas de masse vésicale palpable.

Objectif n°1 : Définir l'hématurie macroscopique et l'hématurie microscopique.

Question 2 : Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez-vous pour confirmer l'hématurie ?

- A. Une cytologie urinaire
- B. Un ECBU
- C. Une bandelette urinaire
- D. Une NFS
- E. L'épreuve des 3 verres

L'examen complémentaire confirme l'hématurie et vous suspectez une tumeur vésicale.

Objectif n°10 : Citer les principales causes d'hématurie d'origine rénale, vésicale et uréthro- prostatique

Question 3 : Quel(s) sont le(s) les élément(s) en faveur d'une tumeur vésicale chez ce patient ?

- A. L'exposition professionnelle
- B. Le tabagisme
- C. L'hématurie initiale
- D. La pollakiurie
- E. Une alimentation riche en viande

Question 4 : quel examen d'imagerie doit être réalisé de première intention ?

- A. Une IRM pelvienne
- B. Un uroscanner
- C. Une scintigraphie MAG 3
- D. Une échographie vésico-rénale
- E. Un Arbre urinaire sans préparation (AUSP)

- 1) Quels sont, parmi les suivants les diagnostics possibles chez une fille de 7 ans, présentant une hématurie macroscopique intermittente avec présence de caillots :**
 - A) Une cystite hémorragique
 - B) Une GNA post infectieuse
 - C) Une lithiase rénale
 - D) Une tumeur vésicale
 - E) Un syndrome d'Alport

- 2) Dans la GNA post streptococcique de l'enfant, l'hématurie :**
 - A) Est associée à des cylindres hématiques
 - B) Est associée à des hématies déformées
 - C) Constitue un élément de gravité
 - D) Peut être absente dans les formes paucisymptomatiques
 - E) Peut-être microscopique

- 3) Quels examens complémentaires demandez-vous chez un garçon de 9 ans, présentant un syndrome néphritique aigu survenant 10 jours après une angine mal traitée :**
 - A) Un dosage de la fraction C3 du complément
 - B) Une échographie rénale
 - C) Une fonction rénale
 - D) Une ponction biopsie rénale
 - E) Une recherche des anticorps antinucléaires

- 4) Chez l'enfant, la GNA post infectieuse peut se révéler par :**
 - A) Une prise de poids
 - B) Une hématurie microscopique isolée
 - C) Un syndrome néphrotique pur
 - D) Une encéphalopathie hypertensive
 - E) Une GNRP

- 5) Dans la GNA post infectieuse de l'enfant**
 - A) La fraction C4 du complément se normalise au bout de 15 jours
 - B) le germe en cause peut être un virus
 - C) L'HTA est constante
 - D) Le début est brutal
 - E) Les formes pauci symptomatiques sont rares

- 6) Chez un enfant de 9 ans, une hématurie macroscopique terminale peut être due à**
 - A) Une cystite aigue hémorragique
 - B) Une néphropathie lupique
 - C) Une tumeur vésicale
 - D) Une polykystose rénale
 - E) Une prise de rifampicine

- 7) **Quel(s) diagnostic(s) peut-on évoquer chez un garçon de 12 ans, présentant une hématurie macroscopique récidivante, avec HTA et PU:**
- A) La GNA post infectieuse
 - B) La maladie de berger
 - C) Une tumeur vésicale
 - D) Un syndrome d'Alport
 - E) Une lithiase rénale
- 8) **quel diagnostic évoquer chez un nourrisson de 7 mois, présentant une hématurie macroscopique avec oedèmes et HTA, survenant 10 jours après une GEA?**
- A) Un néphroblastome
 - B) Une infection urinaire
 - C) Une coarctation de l'aorte
 - D) Un SHU
 - E) Une GNA post infectieuse

Cas clinique

Une fille de 10 ans, sans antécédents particuliers, consulte aux urgences pour une hématurie macroscopique apparue depuis 2 jours, permanente, associée à des céphalées et des douleurs abdominales diffuses. L'examen trouve une enfant apyrétique, eutrophique avec, un œdème du visage, une TA : 15/10 cmHg, une fréquence cardiaque à 105 bpm, une fréquence respiratoire à 18 cpm, un abdomen sans anomalies et un score de glasgow à 15/15. L'examen des membres objective des œdèmes de type rénal bilatéraux avec des 1 lésion de pyodermite au niveau de la cheville droite. L'examen des urines a montré : un aspect bouillon sale avec : L/N : neg HU++++ PU++ Bilan biologique : urée : 19 mmol/l , créatinine : 120 μ mol/l , Na : 131 mmol/l , K : 4.5 mmol/l, protidémie : 45 g/l , albuminémie : 25 g/l , PU de 24h : 200 mg/kg/j

- 1) **Les éléments en faveur de l'origine glomérulaire de l'hématurie dans ce cas sont :**
- A) L'absence de caillots
 - B) L'aspect bouillon sale
 - C) Le caractère permanent
 - D) Les douleurs abdominales
 - E) La présence d'une HTA
- 2) **En se basant sur les données cliniques et biologiques, les diagnostics possibles sont :**
- A) Une GNA post infectieuse
 - B) Une Infection urinaire
 - C) Une lithiase rénale avec IRA obstructive
 - D) Une néphropathie lupique
 - E) Un syndrome néphrotique pur

3) Afin d'étayer votre diagnostic vous allez compléter par :

- A) Une échographie rénale
- B) Une recherche des AAN
- C) Un dosage des ASLO
- D) Un dosage de C3 et CH50
- E) Un ECBU

Au bout de 48 h, une biopsie rénale a été réalisée devant une anurie persistante, et a montré un aspect de prolifération endo-capillaire exsudative globale et diffuse avec à l'immunofluorescence, un dépôt endo et extra-membraneux de C3, avec prolifération extra-capillaire.

4) Quel serait votre diagnostic ?

- A) Une glomérulonéphrite membrano-proliférative
- B) Une glomérulonéphrite rapidement progressive
- C) Une GNA post infectieuse
- D) Une maladie de berger
- E) Une microangiopathie thrombotique